UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Cardiologie
(Intitulé de la station)
avec patient
avec/sans geste clinique

Nom du rédacteur : Bousigues Marie **Date de rédaction :**

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ N° (…) – (Intitulé)

Domaine de compétence n°1 (en sélectionner 1 SEUL) : Entretien/interrogatoire

Domaine de compétence n°1 (en sélectionner 1 SEUL) : Stratégie de prise en charge

Attendus d'apprentissage de la situation abordée (cf. LISA : Catégorie:Situation de départ NG — LiSA (uness.fr)**):**

1- 161

2- 185

Patient simulé nécessaire à la station : OUI, homme, 20-25 ans

Matériel nécessaire à la station

- Mannequin NON
- Brancard NON

-

Exemple d'instructions au patient simulé

Rappel : seules les réponses précisées ci-dessous et les instructions peuvent être verbalisées. Le patient simulé ne doit rien dire d'autres que ce qui est précisé.

Synospis : (décrivez en quelques lignes ici le résumé du rôle et précisez s'il y a un contact physique ou non)

Vous avez 25 ans et vous êtes étudiant(e) en STAPS. Depuis une semaine vous ne vous sentez pas bien, avec une sensation de fièvre modérée, des courbatures inhabituelles et une fatigue inhabituelle. Depuis le matin vous avez une douleur thoracique qui ne passe pas avec du paracétamol, et vous vous rendez chez un médecin généraliste en fin de journée parce que la douleur ne passe pas et vous avez même l'impression qu'elle a augmenté.
Le médecin généraliste va vous interroger et vous examiner.

Identité/Contexte (éléments indispensables)	Nom : Dupont Prénom : Martin Age : 25 ans Etudiant en STAPS Célibataire, vit en colocation en résidence CROUS
Antécédents	Pas d'antécédent
Médicaments actuels/ Toxiques	*Pas de traitement, pas de tabac, alcool occasionnel en soirées, pas d'autre toxique*
Etats d'esprit/ comportement	Posture : assis, penché en avant Douleur : moyenne Angoisse : forte Colère : absente
Déroulement du scénario	Vous êtes assis. Lorsque l'étudiant vous demande pourquoi vous venez, commencez par : *Ex : "**Ca fait une semaine que je ne me sens pas très bien, et là j'ai mal dans la poitrine depuis ce matin."*** Puis répondez aux questions de l'étudiant (cf tableau ci-dessous) et ne dévoilez les informations que s'il vous les demande spécifiquement. Pas d'examen clinique, juste un entretien/interrogatoire.

Autres questions à poser au médecin, à quel moment	

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Vous ne répondrez aux questions suivantes que si l'évalué (étudiant-médecin) vous les pose. Si les questions de l'étudiant-médecin ne sont pas listées ci-dessous, répondre « je ne sais pas ».

Questions éventuellement posées par l'étudiant - médecin	**Réponses à donner par le patient simulé**
Utiliser un vocabulaire simple sans jargon médical *Si les questions sont compliquées le patient doit dire : « Comment ? Je ne comprends pas la question. »*	
Avez-vous déjà eu une douleur comme celle que vous avez aujourd'hui ?	Non, jamais, c'est la première fois que j'ai mal comme ça.
Avez-vous un antécédent de cardiopathie congénitale / aviez-vous une malformation cardiaque à la naissance ?	Non.
Y a-t-il un antécédent familial d'infarctus du myocarde ?	Non
Y a-t-il un antécédent personnel ou familial d'embolie pulmonaire ?	Non
Y a-t-il un antécédent personnel ou familial de déchirure de l'aorte (dissection aortique) ?	Non
Avez-vous une maladie congénitale ou acquise (type VIH) pouvant altérer votre système immunitaire, ou prenez-vous des médicaments pouvant altérer votre système immunitaire ?	Non
Y a-t-il une personne de votre entourage qui aurait contracté une tuberculose récemment ?	Non, j'aurais attrapé la tuberculose ?
Etes-vous traité actuellement pour un cancer ?	Non, j'ai un cancer docteur ?
Prenez-vous des traitements au quotidien ?	Non
Fumez-vous ? Prenez-vous de l'alcool ? Des drogues ?	Je ne fume pas, je ne me drogue pas, je bois de l'alcool de temps en temps, en soirée
Que -faites-vous dans la vie ?	Je suis étudiant en STAPS
A quelle fréquence faites-vous de sport ?	4x par semaine environ
Avez-vous des allergies ?	Non, pas à ma connaissance
Quand a commencé la douleur thoracique précisément ?	Depuis ce matin, elle était là quand je me suis réveillé.

TUT'ECOS

Pouvez-vous me dire où est précisément cette douleur ? Est-ce qu'elle irradie dans le dos, l'épaule ou la mâchoire ?	Elle est là *Poser la main sur le sternum* Non
Sur une échelle de 0 à 10, à combien coteriez-vous cette douleur, sachant que 0 signifie une absence de douleur et 10 c'est la pire douleur que vous puissiez imaginer.	6/10 actuellement.
Avez-vous noté qu'une position ou un médicament calmait votre douleur ?	J'ai pris du doliprane mais ça n'a pas calmé la douleur. Je crois que quand je me penche en avant ça va un peu mieux.
Avez-vous noté une position qui augmentait la douleur ?	Oui, je crois.
Qu'est-ce qui augmente la douleur ?	Ca me fait très mal quand j'inspire
Est-ce que le fait d'être allongé sur le dos augmente la douleur ?	Oui
Est-ce que la douleur est augmentée à l'inspiration ?	Oui
Est-ce la douleur est augmentée quand vous toussez ?	Oui
Avez-vous d'autres symptômes que cette douleur thoracique ?	J'ai un peu de fièvre depuis une semaine, avec des courbatures et une fatigue que je n'arrive pas à expliquer
A quelle heure avez-vous pris le dernier doliprane ?	Vers 14h, donc c'était il y a 4h environ
Avez-vous des troubles du transit ou des difficultés pour faire pipi ?	Non
Avez-vous une maladie qui rend votre sang trop fluide ?	Non
Est-ce que vous prenez des médicaments qui pourraient fluidifier voter sang ?	Non
Avez-vous déjà pris de l'aspirine/de l'ibuprofène ?	Oui, je crois.
Est-ce que vous avez eu des symptômes qui sont apparus lorsque vous preniez de l'aspirine ou de l'ibuprofène comme des difficultés à respirer, une rougeur cutanée, un œdème de quincke… ?	Non
Avez-vous un ulcère gastro-duodénal ?	Non, mais je crois que mon père en a un.

TUT'ECOS

Instructions à l'étudiant

Vous êtes médecin généraliste dans un cabinet de ville et recevez en consultation un homme de 25 ans que vous voyez pour la première fois pour douleur thoracique.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Réaliser l'interrogatoire ciblé, demander les examens complémentaires nécessaires et énoncer votre principale hypothèse diagnostique.
2. Expliquer la prise en charge au patient en fonction de votre hypothèse diagnostique principale.

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tache 1	
Recherche d'antécédents de cardiopathie congénitale	
Recherche un syndrome grippal/contexte viral	
Recherche des allergies	
Demande le siège ET les irradiations de la douleur thoracique (donner le point si 2 items)	
Demande si la douleur est exacerbée à l'inspiration	
Cotation de la douleur sur une échelle numérique expliquée au patient	
Demande les examens complémentaires pertinents : - Electrocardiogramme	
Demande les examens complémentaires pertinents : Echographie transthoracique	
Demande les examens complémentaires pertinents : *(donner le point si les 3 items sont cités)* Bilan biologique : NFS, ET CRP ET troponine	
Enoncer votre hypothèse diagnostique la plus probable : PERICARDITE SANS SIGNE DE GRAVITE	
Tache 2	
Expliquer qu'il n'y a pas de nécessité d'hospitalisation avec les éléments actuels	
Conseiller l'arrêt du sport jusqu'à disparition des symptômes et normalisation des différents bilans OU pendant 3 mois environ	
Recherche des contre-indications à la prise d'AINS : *(donner le point si les 2 items sont cités)* - Ulcère gastro-duodénal ET - Maladie hémorragique constitutionnelle ou acquise	
Prescrire des AINS ET de la colchicine	
Prévoir une consultation de suivi à une semaine	
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à questionner	1 à 5
Aptitude à structurer / mener l'entrevue	
Aptitude à proposer une prise en charge	

UTILISER IMPERATIVEMENT DES VERBES d'ACTION ex : « Dit » « Énonce » « Palpe » « Écoute »
SEPARER CHAQUE ITEM (ex : « recherche une consommation de tabac » et « quantifie une consommation de tabac » sont deux items différents)

MAXIMUM 15 Items de compétence spécifiques et 5 items de compétences génériques

TUT'ECOS

Choisir les plus pertinents/discriminants

Fournir des schémas pour les points cliniques à évaluer par l'examinateur (cadrans d'examen abdominal, foyers d'auscultation etc.)

Préciser quand l'examinateur doit intervenir pour donner un signe clinique positif

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Pondération (entre 1 et 5)
Tache 1	
Tache 2	
COMPETENCES GENERIQUES	
	Echelle de 1 à 5